

La révélation des hémopathies malignes par la présence d'adénopathies :

(Revue de la littérature)

Pr.Aouati Bitat Ch /Pr zaim L/ Dr. Adjissi M/ Dr Daksi S/ Dr Megaache.A / Dr Kerouani .I / Dr Bougharnout B./Dr.Lahmar.S/Dr.Behat.H
Service de Biologie cellulaire et Génétique médicale – CHU Saadna Abdenour, Sétif
Laboratoire de recherche de gé né tique médicale -Faculté de médecine ,Sétif

Introduction :

Les hémopathies malignes sont des tumeurs atteignant les tissus hématopoïétiques, comme la moëlle osseuse ou les tissus lymphoïdes (ganglions, rate...). Elles constituent un ensemble hétérogène de proliférations néoplasiques des cellules sanguines et de leurs précurseurs. Parmi cet ensemble, on distingue : **les leucémies**, peuvent être lymphoïdes ou myéloïdes, aiguës ou chroniques. **les syndromes myélodysplasiques** et **les lymphomes** qui sont classés en lymphome de Hodgkin (LH) ou en lymphome non hodgkinien (LNH) dont les sous-types sont nombreux. Certaines de ces hémopathies peuvent se révéler initialement par une ou plusieurs adénopathies en l'absence d'autres manifestations cliniques évidentes.

Objectif :

Évaluer, à travers une revue de la littérature, l'intérêt de la cytoponction des adénopathies cervicales et leur analyse au microscope optique dans la révélation et l'orientation diagnostique des hémopathies malignes.

Méthodes :

Dans ce contexte, la Cytoponction ganglionnaire à l'aiguille fine représente une méthode rapide, peu invasive et particulièrement intéressante pouvant indiquer la présence et l'évolution d'une hémopathie maligne.

La cytoponction est réalisée à l'aide d'une aiguille fine, généralement de 23 à 25 G, montée sur une seringue, après repérage clinique et/ou échographique de l'adénopathie.

Après désinfection cutanée, plusieurs passages au sein de la lésion sont réalisés afin d'obtenir un matériel cellulaire représentatif.

Le prélèvement sera ensuite étalé sur des lames, séchés à l'air libre puis colorées au May –Grunwald – Giemsa (M.G.G).

Aspects cytologiques des hémopathies révélées :

L'analyse cytologique des frottis obtenus par cytoponction à l'aiguille fine (FNA) repose sur l'étude minutieuse de la morphologie cellulaire individuelle, du fond du frottis et du polymorphisme cellulaire.

Chaque pathologie indiquée sera dotée par l'aspect cytologique caractéristique :

1)-Lymphome de Hodgkin :

Fond polymorphe dans un contexte inflammatoire dont les Cellules caractéristiques

Cellule de Reed-Sternberg : grandes cellules géantes, souvent binucléées avec de grands nucléoles en "yeux de hibou" et d'un cytoplasme abondant amphophile.

Cellules de Hodgkin (mononucléées) : Variantes uninucléées possédant le même aspect nucléolaire géant.

2)-Lymphome non Hodgkinien (LNH) à précurseurs B ou T : Les LNH se caractérisent sur les frottis par une population lymphoïde monomorphe, rompant avec le polymorphisme habituel d'une adénite réactionnelle, dont la taille et l'aspect des cellules varient selon le sous type :

Lymphome de Burkitt : Prolifération monotone de cellules de taille moyenne, aux noyaux ronds dotés de multiples petits nucléoles bien visibles. Le cytoplasme est étroit, intensément basophile, et vacuolé avec nombreuses mitoses et macrophages à corps tingibles.

Lymphome diffus à grandes cellules B (LGBD) : Population monomorphe de grandes cellules atypiques proéminents (souvent 2 à 3 fois la taille d'un petit lymphocyte), à chromatine vésiculaire et un ou plusieurs nucléoles proéminents au cytoplasme modéré ou abondant, basophile. Fréquence des figures mitotiques et de la nécrose cellulaire en arrière-plan.

Lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) : éléments très hétérogènes en taille avec présence de nombreuses grandes cellules monstrueuses atypiques à noyaux polylobés en fer à cheval pas de nucléole visible .

Lymphome folliculaire : Population dimorphe ou mixte associant des centrocytes à noyaux clivés associée à un nombre variable de centroblastes. Fond est souvent riche en corps lymphoglandulaires (fragments cytoplasmiques basophiles caractéristiques)

Lymphome a cellules du manteau : Cellules de taille petite à moyenne, présentant des contours nucléaires irréguliers, parfois indentés ou fendus (formes centrocyte-like), avec un cytoplasme très restreint et une chromatine finement dispersée.

Lymphome des cellules de la zone marginales : une population hétérogène associant des petites cellules lymphoïdes lymphocyte-like, des cellules de type centrocytaire (noyaux irréguliers ou clivés), des cellules lympho-plasmocytoïdes(noyau excentré et cytoplasme modérément basophile),des cellules lymphoplasmocytaires et plus rarement des cellules monocytoïdes au cytoplasme pale et abondant.

Lymphome lymphoblastique : Population monomorphe de cellules blastiques à rapport nucléocytoplasmique élevé et chromatine fine.

Lymphome a cellules T périphériques ou NK : polymorphisme cellulaire de petites, moyennes et grandes cellules à noyaux irréguliers, nucléoles visibles et cytoplasmes abondants basophiles avec parfois des fines granulations azurophiles évocatrices des cellules NK.

3)- Leucémie lymphoïde chronique (LLC) :

Population monomorphe de petits lymphocytes matures à chromatine condensée en gros blocs et cytoplasme peu abondant, accompagnés de nombreux "noyaux nus" (ombres de Gumprecht).

Il existe deux formes particulières :

LLC à noyaux encochés : dans cette forme les petites cellules lymphoïdes présentent des noyaux au contour irrégulier encoché

LLC lymphoplasmocytoïde : dans cette forme les petites cellules lymphoïdes présentent un cytoplasme plus abondant de basophilie modérée .

Conclusion :

Les hémopathies malignes constituent près de 6,6% de l'ensemble des cancers, qui touche toutes les tranches d'âge. Le syndrome adénomégalique est un signal d'alarme majeur des hémopathies malignes, dominées par les pathologies lymphoïdes. Face à des adénopathies persistantes et inexpliquées L'analyse cytologique permettra un diagnostic rapide contribuant à une prise charge précoce et un pronostic meilleur .



Figure 01: Cellule de Reed-Sternberg LH -MGG

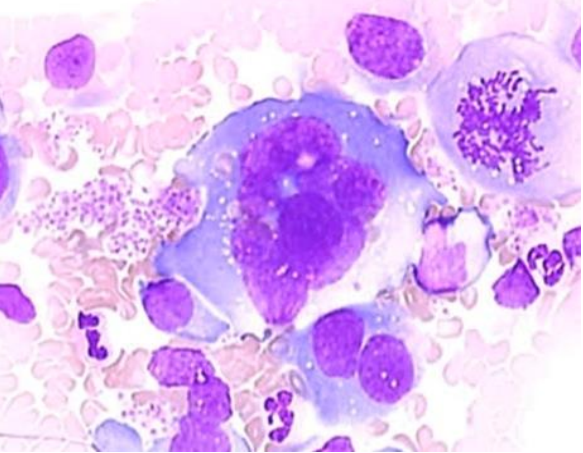


Figure 03: Aspect cytologique du LAGC

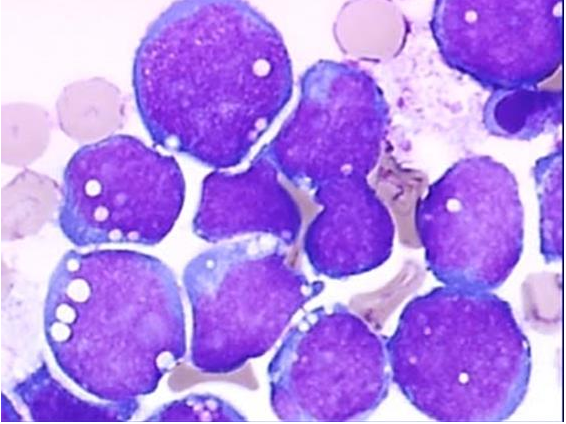


Figure 02: Aspect cytologique du lymphome de Burkitt - MGG.

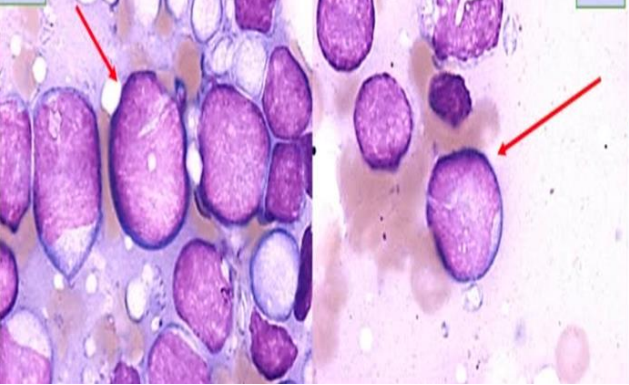


Figure 04: Aspect cytologique du Lymphome folliculaire- MGG.

Références Bibliographiques :

- Johnson KA, Tung K-K, Mead G, Sweetenham J. The imaging of Burkitt's and Burkitt-like lymphoma. Clinical Radiology. 1998;53(11):835–841.
- Das DK, Gupta SK, Pathak IC, Sharma SC, Datta BN. Burkitt-type lymphoma: Diagnosis by fine needle aspiration cytology. Acta Cytologica. 1987;31:1–7.
- Stastny JF, Almeida MM, Wakely PE Jr, Kornstein MJ, Frable WJ. Fine-needle aspiration biopsy and imprint cytology of small non-cleaved cell (Burkitt's) lymphoma. Diagnostic Cytopathology. 1995;12(3):201–207.